



**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Северный государственный медицинский
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра факультетской терапии**

Хронический панкреатит

Работу выполнила: Александрова
А.А, студентка 3 группы 3 курса
лечебного факультета

Проверил: Семёнов А.В, к.м.н.,
доцент кафедры факультетской
терапии СГМУ

Архангельск
2025

Определение

- Хронический панкреатит (ХП) — полиэтиологическое прогрессирующее воспалительно-склеротическое заболевание поджелудочной железы, продолжительностью более 6 месяцев, с постепенным замещением паренхимы органа соединительной тканью и развитием экзокринной и эндокринной недостаточности поджелудочной железы

Эпидемиология

- Частота ХП колеблется в пределах от 0,2% до 0,6% в общей популяции
- Распространенность ХП в России составляет 27,4-50 случаев на 100 тыс. населения, в мире – 42-52 случая на 100 тыс. населения
- Обычно ХП развивается в зрелом возрасте (35-50 лет)
- Летальность после первичного установления диагноза ХП составляет до 20% в течение первых 10 лет, и более 50% – через 20 лет, составляя в среднем 11,9%

Классификация

1. По этиологии:

- Билиарнозависимый
- Алкогольный
- Дисметаболический
- Инфекционный
- Лекарственный
- Идиопатический

2. По функциональным признакам:

- с нарушением внешней секреции поджелудочной железы
- с нарушением внутренней секреции поджелудочной железы.

Классификация

3. По клиническим проявлениям:

- Болевой
- Диспептический
- Сочетанный
- Латентный

4. По характеру клинического течения:

- Редко-рецидивирующий (рецидивы 1-2 раза в год и реже) – легкое течение
- Часто-рецидивирующий (рецидивы 3-4 раза в год) – средней степени тяжести
- С постоянно присутствующей симптоматикой ХП — тяжёлое течение

Классификация

5. По морфологическим признакам:

- Интерстиционально-отечный
- Паренхиматозный
- Фиброзно-склеротический (инударативный)
- Гиперпластический (псевдотуморозный)
- Кистозный

6. Фаза:

- обострение
- затухающее обострение
- ремиссия

Этиология

Современные представления об этиологии ХП отражает классификация **TIGAR-O** (Toxic-metabolic, Idiopathic, Genetic, Autoimmune, Recurrent and severe acute pancreatitis, and Obstructive)

1. Токсический/метаболический

- - алкоголь!
- - табакокурение
- - гипертриглицеридемия
- - гиперкальциемия
- - лекарственные препараты
- - токсины

Этиология

2. Наследственность

- Семейный панкреатит
- Муковсцидоз
- Мутации, повышающие восприимчивость к повреждению на фоне внешних факторов
- Синдромы гипертриглицеридемии
- Редкие, неопухолевые синдромы с вовлечение поджелудочной железы
 - Синдром Швахмана-Даймонда
 - Синдром Йохансона-Близзарда
 - Митохондриальные расстройства (синдром Пирсона)

Этиология

3. Аутоиммунный панкреатит (АИП)

- *АИП тип 1, ассоциированный с IgG4*

- изолированный
- с вовлечением других органов (IgG4 – ассоциированная болезнь)

- *АИП тип 2,*

- изолированный
- в сочетании с болезнью Крона
- в сочетании с язвенным колитом
- с вовлечением других органов

Этиология

4. ХП как следствие рецидивирующего и тяжелого острого панкреатита

- тяжелый острый панкреатит
- рецидивирующий острый панкреатит (более 1 эпизода острого панкреатита)

5. Обструктивный ХП

- стеноз сфинктера Одди
- обструкция протока (опухолью, камнем, периампулярными кистами двенадцатиперстной кишки)
- стриктуры панкреатического протока (осложнение эндоскопических процедур: папиллосфинктеротомии, экстракции конкрементов и т.д.)

Патогенез

- Основным патогенетическим механизмом развития ХП является аутолиз (самопереваривание) в результате активации собственных протеолитических ферментов с развитием отека, коагуляционного некроза и фиброза ткани ПЖ.

Патогенез алкогольного панкреатита

Прямой эффект этанола:

- жировая инфильтрация, повышение синтеза коллагена и повышение проницаемости мембран эндотелия сосудов и эпителия протоков
- Спазм сфинктера Одди

Патогенез алкогольного панкреатита

Стимулирующий эффект алкоголя:

- **Стимуляция выработки ферментов**, не влияя на количество панкреатического сока | —> **Изменение его качественного состава:** повышение концентрации нерастворимого белка и уменьшение содержания бикарбонатов преципитация белка с образованием белковых пробок и обтурация внутрипанкреатических протоков | —> **Разрыв стенки протока** и сосуда вследствие повышения давления | —> **Уклонение ферментов в кровь, их активация** | —> **Асептическое воспаление**

Клиническая картина

- Наиболее типичные клинические проявления ХП – боль в животе и симптомы недостаточности функции ПЖ, однако в ряде случаев клиническая картина заболевания может манифестировать клинической картиной осложнений.
- **Клинические синдромы:**
 - Болевой синдром
 - Синдром желудочной диспепсии
 - Синдром билиарной гипертензии
 - Синдром внешнесекреторной недостаточности
 - Синдром внутрисекреторной недостаточности (диабет).

Болевой синдром

- **Локализация боли:** правые верхние отделы живота, эпигастрий, левое подреберье. Опоясывающие боли характерны при тотальном поражении (при парезе поперечной ободочной кишки). Иррадиация в спину, реже в области пупка с иррадиацией в паховую область, бедра
- **По характеру** давящие, жгучие
- **Провоцируются** приёмом острой, жирной, кислой пищи, возникают через 1-2 часа
- **Длительность:** постоянные мучительные или приступообразные с легкими самокупирующимися приступами продолжительностью по 1–3 дня
- **Облегчаются:** в положении сидя с небольшим наклоном вперед, усиливаются лёжа на спине после приёма пищи

Синдром желудочной диспепсии

- Анорексия
- Тошнота
- рвота (чаще не приносящая облегчения, обильная, многократная)
- раннее ощущение насыщения, может быть отвращение к пище во время обострения
- чувство переполнения после приема пищи
- отрыжка

Синдром билиарной гиперкинезии

- Желтуха
- кожный зуд
- темная моча
- обесцвечивание кала.

Возникает при псевдотуморозной форме ХП или вследствие давления пролиферирующей головкой поджелудочной железы на дистальную часть общего желчного протока.

Синдром внешне- внутрисекретной недостаточности

- **Недостаточность внешнесекреторной функции ПЖ,** проявляющаяся клинически, возникает только при снижении функциональной активности железы более чем на 90%. Клиническими проявлениями нарушения всасывания жиров являются стеаторея и метеоризм, потеря массы тела (у 30-52% пациентов).
- **Эндокринная панкреатическая недостаточность** со временем развивается у 70% пациентов с ХП в виде нарушения толерантности к глюкозе. Сахарный диабет возникает при длительном течении ХП, вероятность возникновения сахарного диабета постепенно возрастает спустя 10 лет от начала манифестации ХП

Определение клинической стадии ХП с оценкой прогноза

Стадия	Признаки	Прогноз
1	Доклиническая. Признаки ХП по данным лучевых методов диагностики	Неизвестен
2	Начальных проявлений. Боль типа «А». Повторные приступы острого панкреатита. Снижение качества жизни. Длительность: 4-7 лет	↑ риск панкреонекроза, осложнений острого панкреатита
3	Персистирующая симптоматика. Боль типа «В». Эндо- и/или экзокринная недостаточность	Трофологическая недостаточность
4	Атрофия ПЖ. Выраженная недостаточность ПЖ. Интенсивность боли снижается, отсутствуют эпизоды острого панкреатита	СД, трофологическая недостаточность. Повышен риск рака ПЖ

Диагностика

- **Лабораторные исследования однократно**(ОАК, ОАМ, Общий билирубин и фракции, АсАТ, АлАТ Амилаза крови Липаза крови ЩФ, ГГТП Копрограмма Сахар крови Кальций крови Общий белок и фракции)
- **Инструментальная диагностика** (Однократно: Rg брюшной полости УЗИ брюшной полости ЭРХПГ. Двукратно: УЗИ поджелудочной железы)
- **Дополнительно по показаниям** (Лапароскопия с прицельной биопсией поджелудочной железы КТ поджелудочной железы Коагулограмма Сахар крови после приема глюкозы (сахарная кривая))

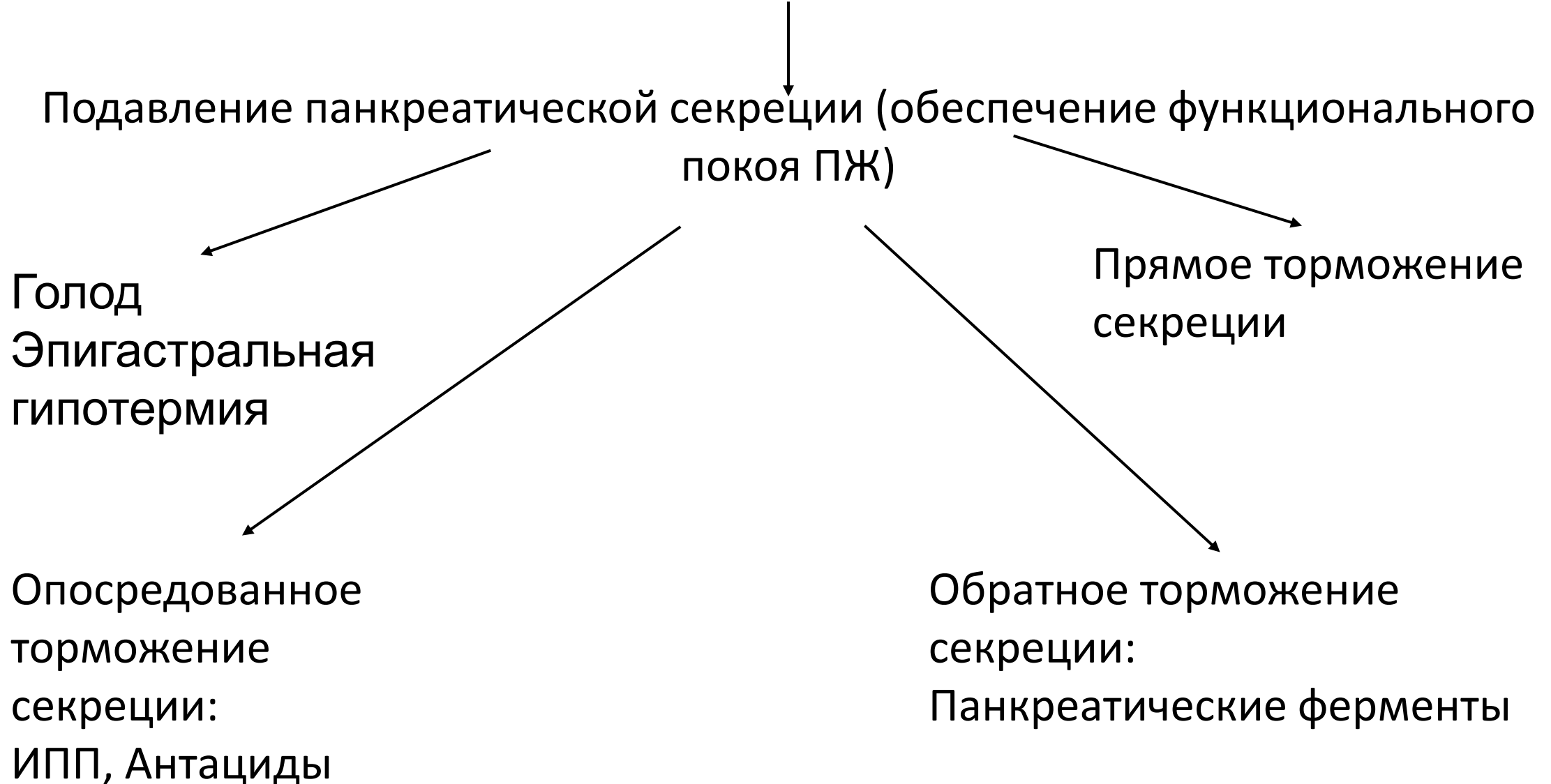
Определение активности воспалительного процесса

- **Общий анализ крови** (лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, ускорение СОЭ).
- **Амилазный тест.** Повышение уровня амилазы в крови появляется через 2 часа от начала обострения и сохраняется в течение 2-3 дней (до 6 суток). Более длительная гиперاميлаземия может свидетельствовать о формирующихся осложнениях (формирование псевдокисты ПЖ).
- **Диастаза (амилаза) мочи.** Диастаза в моче повышается параллельно амилазе крови. Уровень повышения может достигать 100-200 норм уже в первые часы.
- **Липазный тест** (обладает большей специфичностью). Уровень липазы в крови повышается в 5-10 раз с 4-го дня и удерживается до 10-15 дней.
- **Эластазный тест** (иммуноферментный метод). Повышение уровня эластазы-1 (E1) в крови сохраняется дольше, чем повышение амилазы и липазы.

Принципы лечения

- Отказ от употребления алкоголя
- Диета Купирование боли
- Ферментная заместительная терапия
- Коррекция витаминной недостаточности
- Лечение эндокринных нарушений

Терапия при обострении ХП



Купирование болевого синдрома

- Анальгин 50% раствор 2,0 мл 3 раза в день в сочетании с папаверина гидрохлоридом 2% - 2,0 мл 3 раза в день (или платифиллином, атропином) в/м.
- Баралгин по 5,0 мл в/в или в/м.
- Новокаин 0,25% - 100 мл в/в капельно.
- При упорном болевом синдроме все препараты можно вводить в виде «коктейлей» в/в кап., например: новокаин 0,25% - 100 мл, контрикал 30 000 – 40 000 Ед, эуфиллин 2,4% 10 мл, аскорбиновая кислота 5% - 6,0 мл, витамин В6 5% - 2,0 мл, кокарбоксилаза 100 мг. Смесь может вводиться до 2 раз в сутки.
- Наркотические препараты (исключая морфий!) при отсутствии эффекта от коктейлей

Лечение секреторной недостаточности

- **Показания к ЗФТ:** стеаторея, диарея, нутритивная недостаточность, после панкреонекроза/операций на ПЖ
- **Цели:** нормализация нутритивного статуса, предотвращение остеопороза, улучшение качества жизни
- **Схема:** панкреатин (микрочастицы с кишечнорастворимой оболочкой)
 - Базовая доза: 40-50 тыс. ед. 3 р/д
 - Оценка через 6 месяцев
 - При неэффективности (>400-500 тыс. ед./сут) добавить ИПП (омепразол 20 мг 2 р/д)
 - Исключение других причин стеатореи
 - Пожизненная терапия при тяжелой недостаточности

Диетотерапия

- Низкое содержание жира (40-60 г/сут)
- Частый прием небольших (300 г на прием) количеств пищи [?]
Ограничение соли
- Исключение жареной пищи, копченостей, маринадов, солений, экстрактивных веществ, крепких чая и кофе, продуктов твердой и густой консистенции, резко ограничить молочные продукты, богатые кальцием (сыры, творог).
- Углеводы до 200 г/сут
- Запрет на еду после 19 часов